

TEMA 7.15 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Psiquiatría Infantil: Trastornos del Ánimo y Trastornos Ansiosos

PERFIL EUNACOM 1.07.15

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos del ánimo y de ansiedad en la edad pediátrica presentan matices significativos que los diferencian de la presentación en adultos. El enfoque en niños es predominantemente **sistémico y familiar**, priorizando la psicoterapia sobre el tratamiento farmacológico en la mayoría de los casos.

Depresión Infantil

La **depresión** en niños no suele ser un evento aislado del entorno. A diferencia de los adultos, donde los factores biológicos o eventos vitales individuales pesan mucho, en el niño el contexto es el principal motor.

- **Etiología principal:** La **disfunción familiar** es la causa más frecuente. Otros factores críticos incluyen el **bullying**, problemas escolares, abuso sexual o violencia intrafamiliar.
- **Clínica:** Comparte los síntomas clásicos del adulto (tristeza, anhedonia, insomnio, inapetencia). Sin embargo, en niños es muy frecuente la presentación como **cambios bruscos de comportamiento**:
 - Descenso repentino del rendimiento escolar.
 - Conductas de insolencia o irritabilidad (en lugar de tristeza evidente).
- **Tratamiento:**
 1. El pilar fundamental es la **psicoterapia con enfoque sistémico/familiar**.
 2. Se deben **evitar los fármacos** como primera línea.
 3. Los antidepresivos se reservan exclusivamente para casos graves o refractarios bajo supervisión de especialista.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante un niño que previamente funcionaba bien y comienza con irritabilidad o baja en sus notas, siempre se debe realizar una evaluación dirigida del ánimo para descartar una depresión subyacente.

Trastorno Bipolar en la Infancia

El **Trastorno Bipolar** es una patología de fuerte carga genética. Aunque su inicio habitual es en la adultez joven o adolescencia, puede presentarse en escolares.

- **¿Cuándo sospecharlo en niños?**
 - Antecedentes familiares directos de trastorno bipolar.
 - Presencia de episodios de **manía o hipomanía**.
 - Depresiones especialmente **graves o con síntomas psicóticos** a edades muy tempranas.
- **Tratamiento:** A diferencia de la depresión unipolar, el trastorno bipolar en niños **sí requiere fármacos obligatoriamente**. Se utilizan estabilizadores del ánimo como el **Litio** o algunos anticonvulsivantes.

Distimia Infantil

La distimia se define como un ánimo bajo crónico que no llega a cumplir todos los criterios de un episodio depresivo mayor.

- **Causa:** Al igual que la depresión, está muy ligada a la **disfunción familiar**.
- **Criterio temporal diferencial:**
 - En adultos: Se requieren 2 años de síntomas.
 - **En niños y adolescentes: Basta con 1 año** de evolución para realizar el diagnóstico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla del Año: Para el EUNACOM, recuerda que en pediatría el tiempo requerido para diagnosticar distimia se reduce a la mitad (1 año) debido al impacto que este tiempo tiene en el desarrollo del menor.

Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS)

Es el trastorno ansioso más característico de la infancia, aunque puede persistir o iniciarse en adultos.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Su origen suele radicar en un **apego inseguro**. El niño no ha desarrollado la certeza interna de que sus cuidadores regresarán o estarán a salvo, lo que genera una respuesta de estrés desproporcionada ante la separación.

- **Clínica:**
 - Es muy frecuente en la **edad preescolar** (2 años en adelante).
 - **Ansiedad marcada** al separarse de los padres (típicamente al dejarlos en el jardín infantil).
 - **Miedos irracionales:** Temor a que los padres mueran, sufran un accidente o que al propio niño le pase algo malo y no estén sus padres para protegerlo.
 - **Pesadillas** relacionadas con la separación.
 - **Conductas de evitación:** El niño se niega a ir a cumpleaños, casas de amigos o incluso a dormir solo.
- **Manejo:**
 - **Educación:** Explicar a los padres que es un cuadro frecuente.
 - **Exposición progresiva:** Por ejemplo, presencia gradual de los padres en el jardín hasta que el niño se habitúe.
 - **Psicoterapia:** Tanto para el niño como para los padres, trabajando la seguridad del vínculo.

TABLA 7.15.1: CARACTERÍSTICA VS ANSIEDAD POR SEPARACIÓN NORMAL

CARACTERÍSTICA	ANSIEDAD POR SEPARACIÓN NORMAL	TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
Edad	Lactantes (aprox. 8 meses a 1.5 años)	Preescolares y escolares (2+ años)
Intensidad	Leve a moderada, cede rápido	Muy intensa, persistente, interfiere con la vida
Síntomas asociados	Llanto transitorio	Pesadillas, miedos somáticos, evitación

Otros Trastornos Ansiosos en Pediatría

Los niños también pueden padecer **Trastorno de Ansiedad Generalizada**, **Trastorno Obsesivo Compulsivo** o estrés postraumático.

Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en Niños

La gran diferencia con el adulto es la **naturaleza del evento traumático**. En un niño, situaciones que para un adulto son "menores" pueden gatillar un TEPT completo: - Ver una película o dibujos animados de terror (por ejemplo, una bruja o monstruo). - Hospitalizaciones (vividas como abandono o agresión). - Castigos físicos o reprimendas verbales severas.

Resumen de Manejo Farmacológico

En psiquiatría infantil, la regla de oro es la prudencia con el uso de psicofármacos.

TABLA 7.15.2: PATOLOGÍA VS MANEJO INICIAL DE ELECCIÓN		
PATOLOGÍA	MANEJO INICIAL DE ELECCIÓN	¿USA FÁRMACOS?
Depresión	Psicoterapia Sistémica	No (solo en casos graves)
Distimia	Psicoterapia / Educación	No
Trastornos Ansiosos	Educación / Psicoterapia	No
Trastorno Bipolar	Estabilizadores del Ánimo	Sí (Siempre)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es normal que un lactante de 12-18 meses llore al quedarse con un extraño. No se debe patologizar la ansiedad de separación fisiológica propia del desarrollo. El diagnóstico de trastorno se hace cuando la intensidad y la edad son inapropiadas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niña de 10 años, antes alegre y con buen rendimiento escolar, presenta desde hace 4 semanas: tristeza, no quiere ir al colegio, ha bajado sus notas y se encierra en su pieza. La madre refiere que no hay problemas familiares visibles. ¿Cuál debe ser la evaluación prioritaria?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Infantil: Trastornos del Ánimo y Trastornos Ansiosos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La depresión infantil se manifiesta frecuentemente como cambio conductual brusco (baja en notas, irritabilidad) en un niño previamente sano.
- En niños con depresión o trastornos ansiosos se evitan los fármacos; el tratamiento es psicoterapia con enfoque familiar.
- La excepción: el trastorno bipolar en niños sí requiere estabilizadores del ánimo (litio o anticonvulsivantes).
- La distimia en niños y adolescentes requiere solo 1 año de duración (no 2 como en adultos).
- El trastorno de ansiedad de separación ocurre por apego inseguro; la ansiedad intensa al separarse de los padres es su síntoma central.
- En el TEPT infantil el evento traumatizante puede ser mucho menor que en adultos (película de miedo, hospitalización).
- El trastorno bipolar de inicio en la infancia es infrecuente; su diagnóstico se sospecha con depresiones severas/psicóticas o hipomanía y antecedentes familiares.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA INFANTIL: TRASTORNOS DEL ÁNIMO Y TRASTORNOS ANSIOSOS)**PREGUNTA 1**

Niña de 10 años, antes alegre y con buen rendimiento escolar, presenta desde hace 4 semanas: tristeza, no quiere ir al colegio, ha bajado sus notas y se encierra en su pieza. La madre refiere que no hay problemas familiares visibles. ¿Cuál debe ser la evaluación prioritaria?

- A)** Iniciar antidepressivo ISRS directamente
- B)** Descartar bullying, abuso o disfunción familiar oculta; iniciar psicoterapia con enfoque sistémico
- C)** Diagnóstico de trastorno de conducta disocial; intervención sistémica urgente
- D)** Diagnóstico de TEA y derivar a evaluación de neurodesarrollo
- E)** Derivar a pediatría por sospecha de patología orgánica

PREGUNTA 2

Niño de 3 años es llevado al jardín infantil por primera vez. Cada vez que la madre lo deja llora intensamente, se aferra a ella y le pide que no se vaya. Cuando la madre está presente, juega bien con los otros niños. La educadora refiere que la situación dura más de 2 horas. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

- A)** Conducta normal; no requiere intervención
- B)** Trastorno de ansiedad de separación; psicoeducación a los padres y exposición progresiva
- C)** TEA; derivar a evaluación de neurodesarrollo urgente
- D)** Depresión infantil; psicoterapia
- E)** Iniciar benzodiacepinas para el manejo de la ansiedad

PREGUNTA 3

Adolescente de 14 años tiene antecedentes familiares de trastorno bipolar en el padre. Consulta por un episodio de tristeza profunda de 3 semanas con anhedonia, insomnio y anorexia. En la anamnesis se pesquiza que hace 2 meses fue hospitalizado en otra ciudad por un "episodio de euforia" que duró una semana. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

- A)** Depresión mayor en adolescente; psicoterapia sin fármacos
- B)** Trastorno bipolar; estabilizadores del ánimo (litio o anticonvulsivante)
- C)** Trastorno bipolar; iniciar antidepressivo ISRS para la depresión actual
- D)** TDA en adolescente; metilfenidato
- E)** Esquizofrenia de inicio en adolescencia; antipsicótico

RESUMEN: PSIQUIATRÍA INFANTIL: TRASTORNOS DEL ÁNIMO Y TRASTORNOS ANSIOSOS

Los trastornos del ánimo en niños tienen características particulares que los diferencian de los adultos. La depresión infantil tiene como causa más frecuente la disfunción familiar, seguida de bullying, problemas escolares y abuso. La clínica es similar a la de los adultos (tristeza, anhedonia, insomnio, inapetencia) pero puede manifestarse como un cambio conductual brusco: baja en las calificaciones o irritabilidad/insolencia en un niño que antes andaba bien. El tratamiento es psicoterapia (con enfoque sistémico-familiar) sin fármacos habitualmente; solo en los casos más graves se usan antidepressivos. En la distimia infantil, el período mínimo es de 1 año (no 2 como en adultos) y el tratamiento sigue siendo psicoterapia sin fármacos preferentemente. El trastorno bipolar es muy poco frecuente en niños; cuando se presenta, sí requiere estabilizadores del ánimo (litio o anticonvulsivantes), a diferencia de la depresión infantil que evita los fármacos. El trastorno de ansiedad de separación es característico de la edad preescolar y escolar temprana. Su causa es el apego inseguro. Se manifiesta como ansiedad marcada al separarse de los padres, miedo a que algo malo les ocurra a los padres o al niño, pesadillas relacionadas y conductas evitativas de situaciones que impliquen separación. Es normal en lactantes; después de los 2-3 años, si es muy intenso y limita la vida del niño, se diagnostica como trastorno de ansiedad de separación. El tratamiento es educativo y psicoterapéutico (exposición progresiva + trabajo con los padres). Los trastornos ansiosos en niños (TAG, TEPT, TOC) son similares a los del adulto pero mucho menos frecuentes; los fármacos se evitan. En el TEPT infantil el evento traumatizante puede ser mucho menos intenso que en adultos (película de miedo, hospitalización, castigo intenso).